

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

Drépanocytose : 7 enfants sur 10 arrivent trop tard aux urgences de Cocody.

Automédication, tradipraticien, puis urgences : André Marius GRO BI montre que 71,7 % des enfants drépanocytaires arrivent au CHU de Cocody avec plus de 24 heures de retard.

Publié le
23 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Parcours de soins des enfants drépanocytaires admis aux urgences pédiatriques du Centre hospitalier universitaire de Cocody (Abidjan, Côte d'Ivoire) de janvier à décembre 2024 », ***Médecine Tropicale et Santé Internationale*****, vol. 6 n°2, mai 2026.**

01

Contexte

En Côte d'Ivoire, environ 12 à 14 % de la population porte le trait drépanocytaire. Aux urgences pédiatriques du CHU de Cocody, 63 des 800 admissions de 2024 concernaient un enfant atteint de drépanocytose majeure, souvent arrivé dans un état grave.

02

Problème

André Marius GRO BI a retracé le parcours de ces enfants avant leur arrivée aux urgences pour comprendre ce qui retarde la consultation.

03

Méthode

André Marius GRO BI et son équipe ont analysé les dossiers des 60 enfants drépanocytaires SS, âgés de 6 mois à 14 ans, hospitalisés aux urgences pédiatriques du CHU de Cocody du 1er janvier au 31 décembre 2024, dans une étude rétrospective.

04

Résultats

71,7 % des enfants ont consulté plus de 24 heures après le début des symptômes. Avant l'hôpital, 80 % avaient été traités à domicile, dont 75 % par automédication, et 28 % avaient eu recours à la médecine traditionnelle. 63 % des familles avaient un niveau socio-économique bas. Le suivi était jugé mauvais pour 62 % des enfants, et la vaccination incomplète ou non documentée pour 68 %. Le recours à la médecine traditionnelle multiplie par plus de 9 le risque de retard.

05

Ce que ça change

André Marius GRO BI recommande d'améliorer l'accès financier et géographique aux soins, d'éduquer les familles aux signes de gravité, d'associer les tradipraticiens à une référence rapide, de créer un centre de référence pour la drépanocytose et de rendre gratuits les vaccins complémentaires recommandés par l'OMS.

06

Qui peut s'en servir

Ministère de la Santé (programme de lutte contre la drépanocytose), CMU, pédiatres et urgentistes, centres de santé de premier niveau, associations de parents d'enfants drépanocytaires.

07

Statut

Publié (mai 2026).

08

Contact

GRO BI André Marius, Service de pédiatrie médicale, CHU de Cocody, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan · grobimarius2018@gmail.com

09

Appel à l'action

Associations de patients et décideurs : contactez André Marius GRO BI pour accélérer la mise en place d'un parcours de soins dédié aux enfants drépanocytaires.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com